

**SET DE INSTRUMENTE PENTRU
VERIFICAREA COMPETENȚEI**

**ASIGURAREA COMPETENȚEI
FURNIZORILOR DE SERVICII DE
ÎNGRIJIRE DIRECTĂ DE A
IMPLEMENTA INIȚIATIVA SPITAL
PRIETEN AL COPILULUI**





SET DE INSTRUMENTE PENTRU
VERIFICAREA COMPETENȚEI

**ASIGURAREA COMPETENȚEI
FURNIZORILOR DE SERVICII
DE ÎNGRIJIRE DIRECTĂ DE
A IMPLEMENTA INIȚIATIVA
SPITAL PRIETEN AL COPILULUI**



Set de instrumente pentru verificarea competenței: asigurarea competenței furnizorilor de servicii de îngrijire directă de a implementa inițiativa Spital prieten al copilului

ISBN (OMS) 978-92-4-002555-4 (versiunea electronică)

ISBN (OMS) 978-92-4-002556-1 (versiunea tipărită)

© **World Health Organization and the United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020**

Prezentul raport comun reflectă activitățile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Drepturi rezervate. Prezenta lucrare este disponibilă în condițiile licenței Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence ([CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo); <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>).

Conform termenilor acestei licențe, puteți copia, redistribui și adapta lucrarea în scopuri necomerciale, cu condiția ca lucrarea să fie citată în mod corespunzător, după cum se indică mai jos. Indiferent de modul de utilizare a lucrării de față, acesta trebuie să nu sugereze sub nicio formă că OMS sau UNICEF susține o anumită organizație, un anumit produs sau serviciu. Nu este permisă utilizarea neautorizată a logo-ului sau denumirii OMS ori UNICEF. În cazul în care adaptați lucrarea, trebuie să o autorizați sub aceeași licență sau sub o licență echivalentă Creative Commons. În cazul în care realizați o traducere a lucrării de față, adăugați următoarea mențiune de declinare a responsabilității, alături de modalitatea de citare sugerată: „Prezenta traducere nu a fost realizată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sau de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Nici OMS nici UNICEF nu răspunde de conținutul sau corectitudinea prezentei traduceri. Ediția originală în limba engleză este ediția autentică și produce efecte juridice.”

Orice proces de mediere a unor litigii generate în baza licenței se derulează în conformitate cu regulile de mediere ale Organizației Mondiale a Proprietății Intellectuale.

Sugestie privind modul de citare. Competency verification toolkit: ensuring competency of direct care providers to implement the Baby-friendly Hospital Initiative. Geneva: World Health Organization and the United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020. Licență: [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Descriere CIP - Catalogare înaintea publicării. Datele CIP sunt disponibile accesând <http://apps.who.int/iris>.

Vânzare, drepturi și autorizare. Pentru a achiziționa publicații OMS, accesați <http://apps.who.int/bookorders>. Pentru a transmite solicitări privind utilizarea în scopuri comerciale și întrebări privind drepturile și autorizarea, accesați <http://www.who.int/about/licensing>.

Materiale ale unor terți. Dacă doriți să reutilizați anumite materiale din lucrarea de față atribuite unor terți, cum ar fi tabele, figuri sau imagini, responsabilitatea de a stabili dacă este necesară permisiunea pentru refolosirea respectivă și de a obține permisiunea deținătorului drepturilor de autor vă aparține. Riscul privind posibilele revendicări ce rezultă din încălcarea oricărei componente deținute de terți în lucrare revine exclusiv utilizatorului.

Mențiune generală de declinare a responsabilității. Denumirile utilizate și prezentarea materialului din prezenta publicație nu constituie exprimarea opiniei OMS sau UNICEF cu privire la statutul juridic al oricărei țări, teritoriu, oraș sau zonă ori al autorităților acestora sau cu privire la delimitarea frontierelor sau granițelor acestora. Liniile punctate și cele întrerupte din cuprinsul hărților reprezintă linii de graniță aproximative, pentru care este posibil să nu existe încă un acord complet.

Menționarea anumitor companii sau a anumitor produse ale producătorilor nu înseamnă că acestea sunt aprobate sau recomandate de OMS sau UNICEF, în locul altora, care au o natură asemănătoare, și care nu sunt menționate. Cu excepția erorilor și omisiunilor, denumirile produselor brevetate se disting prin majuscule inițiale.

OMS și UNICEF au aplicat toate măsurile de precauție rezonabile pentru a verifica informațiile cuprinse în prezenta publicație. Cu toate acestea, materialul publicat este distribuit fără nicio garanție de niciun fel, exprimată sau implicită. Responsabilitatea pentru interpretarea și utilizarea materialului revine cititorului. În niciun caz OMS sau UNICEF nu va fi răspunzătoare pentru daunele rezultate din utilizarea acestuia.

Design și machetare: Alberto March

Fotografie de copertă ©Stock.adobe.com

CUPRINS

MULȚUMIRI	iv
INTRODUCERE	v
SECȚIUNEA 1: Verificarea competenței	1
SECȚIUNEA 2: Verificarea competențelor	5
<i>Introducere</i>	6
<i>Indicatori de performanță</i>	6
<i>Când se recomandă verificarea competențelor</i>	13
<i>Metode de verificare a competențelor</i>	14
<i>Examinatori</i>	14
SECȚIUNEA 3: Setul de instrumente	16
<i>Instrumentul de verificare a competenței</i>	17
<i>Resursa examinatorului</i>	19
<i>Întrebări cu variante multiple de răspuns pentru verificarea cunoștințelor</i>	21
<i>Studii de caz pentru verificarea integrală a cunoștințelor</i>	21
<i>Instrumente pentru verificarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor prin metoda observării</i>	22
SECȚIUNEA 4: Adaptare în funcție de specificul țării	25
BIBLIOGRAFIE	27
ANEXE WEB	

- Anexa A.** Fișa de verificare a competenței (în funcție de domeniu și de competență)
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333681/9789240009356-eng.pdf>
- Anexa B.** Fișa de verificare a competenței (în funcție de pasul ISPC)
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333683/9789240009363-eng.pdf>
- Anexa C.** Resursa examinatorului (în funcție de domeniu și de competență)
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333684/9789240009370-eng.pdf>
- Anexa D.** Resursa examinatorului (în funcție de pasul ISPC)
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333685/9789240009387-eng.pdf>
- Anexa E.** Întrebări cu variante multiple de răspuns pentru verificarea cunoștințelor
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333687/9789240009394-eng.pdf>
- Anexa F.** Studii de caz pentru verificarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333688/9789240009400-eng.pdf>
- Anexa G.** Instrumente pentru verificarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor prin metoda observării
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333689/9789240009417-eng.pdf>

MULȚUMIRI

Documentul de față a fost elaborat de Elise M. Chapin, Chao-Huei Chen, Louise Dumas, Trish MacEnroe și Linda J. Smith (în ordine alfabetică), în coordonare cu Departamentul pentru Alimentație și Siguranță Alimentară din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și Secțiunea Alimentație, Divizia Programe, din cadrul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii. Laurence Grummer-Strawn și France Bégin au supervizat elaborarea prezentului document.

Ne exprimăm aprecierea pentru feedbackul oferit de actorii internaționali care au contribuit și au comentat pe marginea propunerii de document în perioada decembrie 2019-aprilie 2020, inclusiv personalul, voluntarii și membrii rețelei ISPC, La Leche League International, International Baby Food Action Network, International Lactation Consultant Association și World Alliance for Breastfeeding Action. Dorim să ne exprimăm gratitudinea pentru contribuția oferită de următorii colegi (în ordine alfabetică): Mona Alsumaie, Jeniece Alvey, Maryse Arendt, Melissa Bartick, Julia Bourg, Carmen Casanovas, Janet Guta, Jinhwa Ha, Rukhsana Haider, Maria-Teresa Hernandez-Aguilar, Hiroko Hongo, Mudiwah A. Kadeshe, Isabelle Létourneau-Michaud, Kathleen Marinelli, Ignatus Mosten, Thahira Mustafa, Elie Rouw, Roxana Saunero Nava, Felicity Savage, Paula Schreck, Catherine Sullivan.

În final, dorim să mulțumim numeroșilor coordonatori, administratori de spitale și furnizori de servicii de servicii de îngrijire directă care au implementat inițiativa Spital prieten al copilului la nivel național, regional și de unitate sanitară în ultimii 29 de ani. Eforturile lor susținute și interesul viu pentru sănătatea mamei și copilului au consolidat inițiativa pretutindeni în lume.

INTRODUCERE

În 2018, OMS (Organizația Mondială a Sănătății) și UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) au publicat noul Ghid privind implementarea inițiativei Spital prieten al copilului (ISPC) (denumit în continuare „Ghidul”) (1) care include revizuirile aduse celor zece pași pentru alăptarea la sân corectă (cei zece pași). Cei zece pași constituie fundamentul ISPC. Una dintre cele mai importante modificări aduse celor zece pași vizează pasul doi, care în prezent are următoarea formulare: *„Se asigură că personalul are cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a sprijini alăptarea la sân”*. Această reformulare a pasului doi a introdus o tranziție în cadrul ISPC, de la accentul pus pe formare la concentrarea atenției asupra verificării competenței.

Noul pas doi în cadrul ISPC se axează pe verificări, pentru a asigura că furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă au cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a sprijini alăptarea la sân, în special în primele zile petrecute în maternitate. *Prezentul Set de instrumente* pentru verificarea competenței a fost proiectat pentru a sprijini țările și sistemele de sănătate în demersurile lor de corelare viabilă a competențelor cu practica clinică.

Principiul și practica verificării competenței constituie o componentă importantă a serviciilor de îngrijire și a clinicilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a verificării competenței este un proces complex, în care detaliile sunt deosebit de importante. Verificarea competenței este, în esență, „testul” care indică dacă un furnizor poate desfășura activitatea cu acuratețe și sensibilitate, în mod corect. Dacă furnizorul de servicii de servicii de îngrijire directă nu își poate demonstra în mod clar competența în îndeplinirea unei sarcini profesionale, se impune formarea sau perfecționarea profesională.

Prima secțiune descrie cadrul competențelor, grupând 16 competențe specifice în domeniul facilitării și sprijinirii alăptatului la sân, structurate în șapte domenii.

Cea de-a doua secțiune oferă informații detaliate privind principiul și procesul verificării competenței, detaliile aferente verificării competențelor clinice specifice ISPC, precum și calificările și rolurile examinatorilor. Sunt descrise cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice care alcătuiesc competențele.

Cea de-a treia secțiune descrie detaliat instrumentele utilizate pentru verificarea competenței, inclusiv *Fișa verificării competenței*, *Resursa examinatorului*, întrebările cu variante multiple de răspuns pentru verificarea cunoștințelor, studii de caz care presupun o analiză completă a situațiilor clinice și instrumentele necesare observării abilităților și atitudinilor.

Cea de-a patra secțiune abordează posibilitățile de adaptare a instrumentelor din *Set* în funcție de specificul fiecărei țări.



CADRUL COMPETENȚELOR

SECȚIUNEA 1: CADRUL COMPETENȚELOR

Alimentația și nutriția nou-născutului constituie forma de bază de îngrijire a acestuia. Laptele matern oferit direct de la sânul mamei constituie modalitatea normală și optimă de hrănire a sugarului. „Alăptarea la sân reprezintă o modalitate fără egal de a asigura alimentația ideală pentru creșterea și dezvoltarea sănătoasă a sugarului; de asemenea, constituie o parte integrantă a procesului reproductiv, cu implicații importante pentru sănătatea mamei” (2).

Deși alăptarea la sân este modalitatea cea mai naturală de hrănire a sugarului, aceasta nu constituie un dat natural pentru toate mamele și pentru toți copiii. Necesită o combinație de practici de îngrijire timpurie adecvate și sprijin permanent asigurat de personal sanitar calificat. ISPC își propune să asigure că mamele și nou-născuții beneficiază de „îngrijiri oportune și adecvate înaintea și în timpul șederii lor într-o unitate care furnizează servicii de maternitate și neonatologie...” (1). Ghidul OMS/UNICEF din 2018 a consolidat ISPC, pentru a facilita adoptarea sa de către toate spitalele și maternitățile, oriunde în lume.

Competența este definită ca reprezentând „capacitatea de a utiliza un ansamblu de cunoștințe, abilități și comportamente pentru a îndeplini cu succes activități, roluri sau responsabilități identificate” (3). Unul dintre obiectivele majore ale ISPC constă în garantarea competenței specialiștilor și cadrelor de conducere din domeniul sănătății în punerea în aplicare a celor zece pași. Revizuirea celor zece pași prezentați în Ghidul din 2018 a introdus o modificare importantă a pasului doi, reprezentând o schimbare de paradigmă, de la cerința efectuării unui număr de ore de formare profesională („curs cu durata de 20 de ore”) la confirmarea faptului că toți furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă¹ au competențele necesare pentru a asigura furnizarea îngrijirilor în mod consecvent și etic. Pentru a furniza îngrijiri bazate pe dovezi, cu compasiune și în condiții de siguranță, este esențial ca personalul să aibă cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare. Formarea personalului și/sau educația formală continuă să fie importante în dobândirea cunoștințelor și abilităților tehnice. OMS și UNICEF au pus la dispoziție materiale actualizate, care să sprijine demersurile de formare (4). Cu toate acestea, dezvoltarea capacității impune și verificarea competenței, pentru fiecare membru al personalului sanitar. Astfel, accentul se pune acum pe verificarea acestora. Pentru a fi realizată în toate unitățile sanitare, această schimbare majoră de paradigmă necesită diferite instrumente.

Manualul de față propune un *Set de instrumente* cuprinzător în sprijinul țărilor, sistemelor de sănătate și unităților sanitare individuale, în scopul evaluării competenței personalului în ceea ce privește cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru implementarea celor zece pași. *Setul de instrumente* introduce un cadru (a se vedea **tabelul 1**) constând în 16 competențe specifice, grupate în șapte domenii. Acest cadru înlocuiește lista celor 20 de competențe propusă de Ghidul ISPC din 2018, pentru a reflecta cu mai multă acuratețe cele mai importante aspecte ale îngrijirii, necesare în maternități.

Primul domeniu descris este cel al procedurilor esențiale de management la care trebuie să participe furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă pentru a crea mediul necesar. Abilitățile de bază includ comunicarea și consilierea eficace, care se aplică transversal la nivelul tuturor competențelor clinice. Continuă apoi, trecând prin fiecare etapă perinatală de-a lungul acestui continuum de îngrijire și servicii, începând cu perioada antenatală, până la externarea din maternitate. Toți furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă care activează în unități care oferă servicii de maternitate și neonatologie trebuie să demonstreze că dețin aceste competențe în ceea ce privește aspectele legate de consiliere și sprijin pentru alăptarea la sân.

1 *Furnizor de servicii de îngrijire directă*: orice persoană care furnizează servicii de educație, evaluare, sprijin, intervenție, asistență și/sau urmărire în domeniul hrănirii sugarului. În prezentul document, noțiunile de furnizor de servicii de sănătate, personal, lucrător în domeniul sănătății, specialist în domeniul sănătății descriu toate furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă.

Tabelul 1. Lista competențelor necesare pentru punerea în aplicare a celor zece pași pentru alăptarea la sân corectă

DOMENIUL 1: Proceduri de management esențiale în sprijinul celor zece pași
01. Punerea în aplicare a <i>Codului</i> în unitatea sanitară
02. Explicarea politicilor privind hrănirea sugarului și sistemele de monitorizare ale unității sanitare
DOMENIUL 2: Abilități de bază: comunicarea în mod credibil și eficace
03. Utilizarea abilităților de ascultare și învățare atunci când angrenează mama într-o conversație
04. Utilizarea abilităților necesare pentru a clădi încrederea și a oferi sprijin atunci când angrenează mama într-o conversație
DOMENIUL 3: Perioada prenatală
05. Încurajarea discuțiilor pe tema alăptării la sân în perioada antenatală
DOMENIUL 4: Naștere și imediat post-partum
06. Punerea în aplicare a contactului direct, imediat, piele-pe-piele
07. Facilitarea alăptării la sân în prima oră, în funcție de semnele de foame ale sugarului
DOMENIUL 5: Aspecte esențiale pentru mama care alăptează la sân
08. Discutarea modului în care funcționează alăptarea cu mama
09. Sprijinirea mamei să atașeze corect copilul la sân
10. Ajutarea mamei să răspundă la semnele de foame ale sugarului
11. Ajutarea mamei să gestioneze extragerea laptelui
DOMENIUL 6: Ajutarea mamei și copilului cu nevoi speciale
12. Ajutarea mamei să alăpteze la sân un copil cu greutate mică la naștere sau bolnav
13. Ajutarea mamei al cărei copil are nevoie și de alte lichide, în afară de laptele matern
14. Ajutarea mamei care nu își hrănește copilul la sân direct
15. Ajutarea mamei să prevină sau să soluționeze dificultățile legate de alăptarea la sân
DOMENIUL 7: Îngrijirea la externare
16. Asigurarea unei tranziții line după externare



VERIFICAREA COMPETENȚELOR

SECȚIUNEA 2: VERIFICAREA COMPETENȚELOR

Introducere

Documentul de față include un *Set de instrumente pentru verificarea competenței* care își propune să sprijine unitățile sanitare și educatorii să verifice competențele de bază ale diferitelor categorii de furnizori de servicii de servicii de îngrijire directă (asistenți medicali, moașe, medici etc.) în furnizarea serviciilor de bază de sprijinire a alăptării la sân, bazate pe dovezi.

Furnizorii competenți de servicii de servicii de îngrijire directă pot demonstra că au cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a furniza servicii de îngrijire și sprijin cu compasiune, în condiții de siguranță, tuturor mamelor și nou-născuților, în contextul celor zece pași. Rezultatele învățării atent definite presupun că persoanele evaluate trebuie să știe: ce trebuie să facă (cunoștințe), cum trebuie să pună cunoștințele în aplicare (abilități) și când trebuie să pună abilitățile în aplicare într-un cadru etic adecvat, utilizând acele cunoștințe (atitudini și comportamente) (5). Aceste noțiuni au fost definite după cum urmează (3):

Cunoștințe (C)	reprezintă înțelegerea teoretică sau practică a unui subiect, dobândită prin educație formală sau prin experiență practică.
Abilități (D)	reprezintă capacitatea de a duce la îndeplinire în mod corespunzător o activitate. Acestea includ abilitățile cognitive, de comunicare, interpersonale și de rezolvare a problemelor.
Atitudini (A)	reprezintă comportamentul, modul sau modalitatea în care acționăm, în raport cu propria persoană sau cu alții.

Cunoștințele, abilitățile și atitudinile sunt necesare furnizorilor de servicii de servicii de îngrijire directă pentru a putea interveni la nivel clinic, în marja celor zece pași. Implementarea celor zece pași în maternități necesită cunoștințe, abilități și atitudini care nu se limitează la cele necesare pentru asigurarea sprijinului de bază pentru alăptarea la sân. ISPC presupune aspecte etice legate de îngrijirea și serviciile acordate tuturor mamelor, sprijinite de politicile unității sanitare și de respectarea *Codului internațional de comercializare a înlocuitorilor laptelui matern* (denumit în continuare *Codul*) (8). Furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă trebuie să sprijine deciziile în cunoștință de cauză luate de femei în privința alimentației și bunăstării copiilor lor, presupunând mai mult decât sprijinirea alăptatului la sân în context clinic. ISPC participă activ la asigurarea unor medii propice pentru implementarea durabilă în cadrul unității sanitare, astfel încât toate mamele și toți sugarii să poată beneficia de îngrijirea bazată pe dovezi, individualizată, asigurată cu compasiune pe care o merită, de la toți furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă care vizează atingerea aceluiași obiectiv. În acest context, *Setul de instrumente pentru verificarea competenței* include toate competențele considerate necesare pentru implementarea celor zece pași.

Indicatori de performanță

Setul de instrumente pentru verificarea competenței include indicatori de performanță pentru a documenta dobândirea competențelor necesare de către un lucrător din domeniul sănătății. Pentru fiecare competență sunt enumerați doi sau mai mulți indicatori de performanță. Aceștia constituie enunțuri măsurabile care descriu în mod specific de ce este capabil furnizorul de servicii de servicii de îngrijire directă.

Indicatorii de performanță constituie unități de măsură care reflectă competența unui furnizor de servicii de servicii de îngrijire directă de a proteja, promova și sprijini alăptatul la sân într-o unitate sanitară care furnizează servicii de maternitate și neonatologie. De asemenea, măsoară capacitatea de a implementa cei zece pași (**tabelul 2**). Unii indicatori sunt relevanți pentru mai mulți pași. În special, indicatorii de performanță din cadrul domeniului doi: „Abilități de bază: comunicarea în mod credibil și eficient” sunt în mod inerent importanți pentru pașii trei-zece, deoarece abilitățile de consiliere constituie baza tuturor interacțiunilor cu mamele. Și alți indicatori se aplică în cazul mai multor pași.

Tabelul 2. Cei zece pași

Pasul 1.A	Respectă pe deplin <i>Codul internațional de comercializare</i> a înlocuitorilor laptelui matern și rezoluțiile pertinente ale Adunării Mondiale a Sănătății.
Pasul 1.B	Are o politică scrisă privind hrănirea sugarului care este comunicată periodic personalului și părinților.
Pasul 1.C	Instituie sisteme de monitorizare continuă și de gestionare a datelor.
Pasul 2	Se asigură că personalul are cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a sprijini alăptarea la sân.
Pasul 3	Discută importanța și gestionarea alăptatului la sân cu femeile însărcinate și cu familiile acestora.
Pasul 4	Facilitează contactul imediat și neîntrerupt piele-pe-piele și sprijină mama să inițieze alăptarea la sân cât mai curând posibil după naștere.
Pasul 5	Sprijină mama să inițieze și să continue alăptatul la sân și să gestioneze dificultățile obișnuite.
Pasul 6	Nu oferă nou-născutului alăptat la sân alimente sau lichide, altele decât laptele matern, cu excepția cazurilor cu indicație medicală.
Pasul 7	Asigură posibilitatea ca mama și copilul să rămână împreună și 24 de ore pe zi.
Pasul 8	Sprijină mama să recunoască semnele de foame la sugar și să răspundă la acestea.
Pasul 9	Consiliază mama în privința utilizării și riscurilor aferente biberoanelor, tetinelor și suzetelor.
Pasul 10	Coordonează externarea astfel încât părinții și copilul lor au acces în timp util la sprijin și îngrijire permanente.

Indicatorii de performanță au la bază o abordare preventivă în domeniul îngrijirii, cu scopul de a sprijini mamele să ia propriile decizii privind bunăstarea copiilor lor. Atunci când o persoană știe de ce este importantă o intervenție, o pune mai ușor în practică. Cei mai mulți indicatori de performanță includ sfaturi anticipative pentru mame, astfel încât să devină autonome în procesul de îngrijire a sugarului atunci când sunt externate din spital, indiferent de deciziile acestora privind hrănirea propriului copil.

De exemplu, competența cinci și pasul trei vizează consilierea antenatală pe tema alăptării la sân. Indicatorii de performanță care măsoară această competență sau capacitatea de a pune în aplicare acest pas sunt următorii:

Angrenarea mamei într-o conversație despre trei aspecte legate de importanța alăptatului la sân.	Evaluarea unui număr de cel puțin trei aspecte legate de cunoștințele mamei despre alăptatul la sân, pentru a completa lacunele și a corecta inexactitățile.	Angrenarea gravidei într-o conversație despre cel puțin patru practici de îngrijire de care va beneficia diada mamă-sugar în cadrul maternității, în sprijinul alăptării la sân.
--	--	--

SECȚIUNEA 2: VERIFICAREA COMPETENȚELOR

Furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă trebuie să știe ce să explice mamei, de ce este important, cum trebuie să facă ceea ce este necesar și cum să procedeze respectând ritmul și îngrijorările mamei. Această competență vizează cunoștințele teoretice pe care trebuie să le dețină furnizorii de servicii de servicii de îngrijire directă și integrează abilitățile și atitudinile care îi vor ajuta să transmită mesajul în mod eficace și judicios diferitelor mame.

Fiecare indicator de performanță reprezintă o singură acțiune, prin urmare, este exprimat printr-un singur verb de acțiune. De exemplu, formularea: „Describe mamei cel puțin 4 semne ale transferului adecvat de lapte în primele câteva zile” cuprinde numai verbul de acțiune „descrie”, nu „descrie și ilustrează”, pentru care persoana nu poate fi evaluată ca fiind competentă sau nu printr-o singură întrebare. Verbele de acțiune precum „enumeră, descrie sau explică” necesită numai redarea cunoștințelor, pe când verbele precum „evaluează, demonstrează sau ajută” impun raționament clinic, planificare și comunicare.

Tabelul 3 enumeră indicatorii de performanță, fiecare corelat cu competența aferentă și cu pasul relevant, indiferent dacă se referă la abilități sau la atitudini, precum și modul în care se efectuează verificarea.

Tabelul 3. Lista indicatorilor de performanță

Indicator de performanță	Competența evaluată	Pasul ISPC	Cunoștințe, abilități sau atitudini	Tipul verificării
1. Enumeră cel puțin trei produse tratate în Cod.	01	1A	C	Întrebare sau studiu de caz
2. Descrie cel puțin trei modalități prin care furnizorul de servicii de servicii de îngrijire directă protejează alăptarea la sân în practică.	01	1A	C	Întrebare sau studiu de caz
3. Descrie cel puțin o modalitate în care trebuie să răspundă furnizorul de servicii de servicii de îngrijire directă dacă i se prezintă informații furnizate de producători și/sau distribuitori de produse care intră sub incidența Codului.	01	1A	C	Întrebare sau studiu de caz
4. Descrie cel puțin un tip de stimulent financiar sau material care îi poate fi oferit furnizorului de servicii de servicii de îngrijire directă de către un producător și/sau distribuitor de produse care intră sub incidența Codului.	01	1A	C	Întrebare sau studiu de caz
5. Descrie cel puțin un tip de prejudiciu care se poate produce dacă furnizorul de servicii de servicii de îngrijire directă acceptă stimulente financiare sau materiale.	01	1A	C	Întrebare sau studiu de caz
6. Explică cel puțin două modalități prin care unitatea sanitară se asigură că nu sunt promovate formule de lapte pentru sugari, biberoane sau tetine, nicăieri în perimetrul unității care oferă servicii de maternitate și neonatologie, sau de niciun furnizor de servicii de servicii de îngrijire directă.	01	1A	C	Întrebare sau studiu de caz
7. Descrie cel puțin două elemente care sunt incluse în politica unității sanitare privind hrănirea sugarilor.	02	1B	C	Întrebare sau studiu de caz
8. Explică cel puțin trei modalități în care politica unității sanitare privind hrănirea sugarilor afectează activitatea unui furnizor de servicii de îngrijire directă în cadrul respectivei unități.	02	1B	C	Întrebare sau studiu de caz

Indicator de performanță	Competența evaluată	Pasul ISPC	Cunoștințe, abilități sau atitudini	Tipul verificării
9. Explică cel puțin două motive pentru care este importantă monitorizarea practicilor spitalicești pentru asigurarea calității îngrijirii.	02	1C	C	Întrebare sau studiu de caz
10. Explică cel puțin două modalități prin care sunt monitorizate practicile în cadrul respectivei unități.	02	1C	C	Întrebare sau studiu de caz
11. Demonstrează cel puțin trei aspecte legate de abilitățile de ascultare și de învățare atunci când vorbește cu mama.	03	3-10	C-D-A	Observare
12. Demonstrează cel puțin trei modalități de adaptare a stilului și conținutului comunicării atunci când vorbește cu mama.	03	3-10	C-D-A	Observare
13. Demonstrează cel puțin două modalități prin care încurajează mama să își expună opiniile, alocând suficient timp pentru a înțelege și a analiza aceste opinii.	04	3-10	C-D-A	Observare
14. Descrie cel puțin trei aspecte ale dezvoltării încrederii și oferirii sprijinului atunci când vorbește cu mama.	04	3-10	C-D-A	Observare
15. Angrenează în conversație o gravidă despre trei aspecte legate de importanța alăptării la sân.	05	3	C-D-A	Observare
16. Evaluează cel puțin trei aspecte legate de cunoștințele gravidei despre alăptarea la sân, pentru a completa lacunele și a corecta inexactitățile.	05	3	C-D-A	Observare
17. Angrenează în conversație o gravidă despre cel puțin patru practici de îngrijire alăptării la sân.	05	3	C-D-A	Observare
18. Explică cel puțin trei motive pentru care contactul imediat și neîntrerupt piele-pe-piele este important pentru mamă.	06	4	C	Întrebare sau studiu de caz
19. Explică cel puțin trei motive pentru care contactul imediat și neîntrerupt piele-pe-piele este important pentru sugar.	06	4	C	Întrebare sau studiu de caz
20. Demonstrează cel puțin trei modalități prin care se poate asigura contactul imediat și neîntrerupt piele-pe-piele între mamă și sugar, indiferent de metoda nașterii.	06	4	C-D-A	Observare
21. Demonstrează cel puțin trei aspecte legate de siguranță care trebuie evaluate în timpul contactului piele-pe-piele între mamă și sugar în primele două ore post-partum, indiferent de metoda nașterii.	06	4	C-D-A	Observare
22. Enumeră cel puțin trei motive pentru care contactul piele-pe-piele NU trebuie întrerupt.	06	4	C	Întrebare sau studiu de caz

SECȚIUNEA 2: VERIFICAREA COMPETENȚELOR

Indicator de performanță	Competența evaluată	Pasul ISPC	Cunoștințe, abilități sau atitudini	Tipul verificării
23. Explică cel puțin două motive pentru care contactul pie-le-pe-piele poate fi întrerupt din motive justificabile din punct de vedere medical.	06	4	C	Întrebare sau studiu de caz
24. *DUPĂ CAZ* Explică cum poate fi menținut contactul pie-le-pe-piele în timpul transferării mamei și sugarului în alt salon sau în altă unitate de recuperare.	06	4	C	Întrebare sau studiu de caz
25. Angrenează mama într-o conversație despre cel puțin trei motive pentru care suptul la sân în prima oră este important, atunci când sugarul este pregătit.	06	4	C-D-A	Observare
26. Demonstrează cel puțin trei aspecte legate de siguranța nou-născutului în primele două ore după naștere.	07	4	C-D-A	Observare
27. Descrie mamei cel puțin trei comportamente ale sugaru-lui înainte de a suga activ la sân.	07	4	C-D-A	Observare
28. Descrie cel puțin șase aspecte esențiale pe care fiecare mamă care alăptează ar trebui să le știe sau să le demonstreze.	07	5,8	C	Întrebare sau studiu de caz
29. Angrenează mama într-o discuție despre cel puțin trei mo-tive pentru care este importantă alăptarea exclusivă la sân.	08	3,6	C-D-A	Observare
30. Angrenează mama într-o discuție despre două elemente legate de tiparele de hrănire ale sugarului în primele 36 de ore de viață.	08	5	C-D-A	Observare
31. Descrie mamei cel puțin patru semne ale transferului de lapte corespunzător în primele câteva zile.	08	5	C-D-A	Observare
32. Evaluează o sesiune de alăptare la sân completă obser-vând cel puțin cinci puncte.	09	5,8	C-D-A	Observare
33. Demonstrează cel puțin trei aspecte legate de modalitățile prin care poate ajuta mama să adopte o poziție confortabilă și sigură pentru alăptarea la sân în primele șase ore după naș-tere și ulterior, pe parcursul șederii în spital, după caz.	09	5	C-D-A	Observare
34. Demonstrează cum poate ajuta mama să ghideze copilul către mamelon în poziția de supt în mod eficace și confor-tabil, semnalând cel puțin cinci puncte.	09	5	C-D-A	Observare
35. Angrenează mama într-o discuție despre două aspecte lega-te de importanța plasării mamei și copilului împreună 24h/zi.	10	7	C-D-A	Observare
36. Explică două situații: una pentru mamă și una pentru sugar, când este acceptabil să se separe mama și sugarul în spital.	10	7	C	Întrebare sau studiu de caz
37. Descrie cel puțin două semne precoc de foame și un semn tardiv de foame.	10	8	C	Întrebare sau studiu de caz

Indicator de performanță	Competența evaluată	Pasul ISPC	Cunoștințe, abilități sau atitudini	Tipul verificării
38. Descrie cel puțin patru motive pentru care este importantă hrănirea receptivă.	10	8	C	Întrebare sau studiu de caz
39. Descrie cel puțin două aspecte ale hrănirii receptive (denumită și hrănire la cererea copilului) independent de metoda de hrănire.	10	8	C	Întrebare sau studiu de caz
40. Demonstrează unei mame extragerea manuală a laptelui matern, semnalând opt puncte.	11	5	C-D-A	Observare
41. Explică cel puțin trei aspecte ale depozitării laptelui matern.	11	6	C	Întrebare sau studiu de caz
42. Explică cel puțin trei aspecte ale manipulării laptelui matern.	11	6	C	Întrebare sau studiu de caz
43. Ajută mama să adopte o poziție confortabilă și sigură pentru alăptarea la sân a copilului prematur, prematur târziu sau slăbit, semnalând cel puțin patru puncte.	12	5	C-D-A	Observare
44. Angrenează mama într-o conversație despre copilul prematur, prematur târziu sau cu greutate redusă la naștere care nu sugerează eficient la sân, semnalând cel puțin cinci puncte.	12	5	C-D-A	Observare
45. Angrenează o mamă separată de copilul său prematur sau bolnav într-o conversație despre cel puțin două motive pentru a fi alături de copilul ei în unitatea de terapie intensivă.	12	7	C-D-A	Observare
46. Angrenează mama unui copil prematur, prematur târziu sau vulnerabil (inclusiv în cazul nașterilor multiple) într-o conversație despre cât de important este să observe cel puțin două semne și modificări subtile ale comportamentului pentru a stabili când este oportun să alăpteze la sân.	12	8	C-D-A	Observare
47. Enumeră cel puțin două contraindicații ale alăptării la sân pentru copil și două pentru mamă.	13	6	C	Întrebare sau studiu de caz
48. Descrie cel puțin patru indicații medicale pentru suplimentare la nou-născutul alăptat la sân: două indicații pentru mamă și două pentru nou-născut, atunci când alăptarea la sân nu prezintă îmbunătățiri în urma evaluării și gestionării competente	13	6	C	Întrebare sau studiu de caz
49. Descrie cel puțin trei riscuri asociate hrănirii nou-născutului alăptat la sân cu alimente sau lichide, altele decât laptele matern, cu excepția cazurilor cu indicație medicală.	13	6	C	Întrebare sau studiu de caz
50. Pentru rarele situații medicale în care sugarii nu pot suga la sân sau alăptarea la sân nu este recomandată, descrie, în ordinea preferințelor, alternativele care pot fi aplicate.	13	6	C	Întrebare sau studiu de caz

SECȚIUNEA 2: VERIFICAREA COMPETENȚELOR

Indicator de performanță	Competența evaluată	Pasul ISPC	Cunoștințe, abilități sau atitudini	Tipul verificării
51. Angrenează într-o conversație o mamă care intenționează să își hrănească copilul cu formulă de lapte, semnalând cel puțin trei acțiuni de întreprins.	13	6	C-D-A	Observare
52. Demonstrează cel puțin trei elemente importante ale pregătirii formulei de lapte în condiții de siguranță unei mame care are nevoie de această informație.	13	6	C-D-A	Observare
53. Demonstrează mamei hrănirea sugarului cu cana în condiții de siguranță atunci când este necesar, semnalând cel puțin patru puncte.	14	9	C-D-A	Observare
54. Descrie mamei cel puțin patru pași ai hrănirii unui sugar cu un supliment în condiții de siguranță.	14	6,9	C-D-A	Observare
55. Descrie cel puțin două metode alternative de hrănire, altele decât cu biberonul.	14	9	C	Întrebare sau studiu de caz
56. Angrenează într-o conversație mama care solicită biberone, tetine, suzete fără indicație medicală, semnalând cel puțin trei puncte.	14	9	C-D-A	Observare
57. Angrenează mama într-o conversație despre cel puțin patru modalități de a facilita alăptarea la sân pentru a preveni sau a soluționa majoritatea problemelor obișnuite ale mamei care alăptează (mameloe dureroase, angorjare, mama crede că nu are suficient lapte, sugari care au dificultăți la supt).	15	5,10	C-D-A	Observare
58. Descrie cel puțin patru elemente de evaluat atunci când mama afirmă că copilul său plânge frecvent.	15	8	C	Întrebare sau studiu de caz
59. Descrie cel puțin patru elemente ale sfaturilor anticipative oferite mamei despre tehnici de calmare sau alinare a sugarului înainte de a-i oferi suzeta sau ca alternativă la aceasta.	15	9	c	Întrebare sau studiu de caz
60. Descrie cel puțin surse disponibile local pentru informații în timp util privind hrănirea sugarului și gestionarea problemelor.	16	10	C	Întrebare sau studiu de caz
61. Descrie cel puțin două modalități în care unitatea sanitară se implică în programe în cadrul comunității pentru coordonarea mesajelor privind alăptarea la sân și asigurarea continuității îngrijirii.	16	10	C	Întrebare sau studiu de caz
62. Întocmește planuri individualizate de hrănire la externare împreună cu mama, semnalând cel puțin șase puncte.	16	10	C-D-A	Observare
63. Descrie mamei cel puțin patru semnale de alertă că sugarul este subnutrit sau deshidratat, caz în care trebuie să contacteze un cadru sanitar, după externare.	16	10	C-D-A	Observare
64. Descrie cel puțin trei semnale de alertă pentru mamă, care îi indică faptul că trebuie să contacteze un cadru sanitar, după externare.	16	10	C	Întrebare sau studiu de caz

Când se recomandă verificarea competențelor

Ghidul ISPC din 2018 pledează pentru necesitatea ca sistemele naționale de educație să asigure că furnizorii de servicii de îngrijire directă sunt formați pe tema alăptării la sân ca parte a formării inițiale. Unitățile care furnizează servicii de maternitate și neonatologie trebuie să se asigure că toți furnizorii de servicii de îngrijire directă își perfecționează competențele. Evaluarea competențelor poate identifica lacunele în materie de cunoștințe sau abilități care impun formare suplimentară. Astfel, *Setul de instrumente pentru verificarea competenței* a fost conceput pentru a fi utilizat atât în unitățile sanitare care furnizează servicii de maternitate și neonatologie, cât și în cadrul formării profesionale inițiale. Pentru că descrie competențele minime solicitate tuturor categoriilor de furnizori de servicii de îngrijire directă (moașe, asistenți medicali, medici de familie, obstetricieni, pediatri etc.) din cadrul echipei de îngrijiri perinatale, este conceput astfel încât să fie flexibil și să îndrume perfecționarea cunoștințelor, abilităților și/sau atitudinilor unei persoane, după caz. Impulsul schimbării de paradigmă descrise pentru formula actuală a pasului 2 justifică necesitatea de a face procesul mai relevant și aplicabil pentru toți cei implicați. Redăm mai jos câteva exemple de utilizări posibile:

Verificarea competențelor unui furnizor de servicii de îngrijire directă nou, pentru a identifica lacunele în materie de cunoștințe, abilități și/sau atitudini. În acest caz, trebuie utilizat întregul *Set de instrumente pentru verificarea competenței*, pentru a include toate competențele (instruire specifică, în context clinic; evaluarea finală a competențelor, în contextul formării profesionale inițiale).

- ✓ Verificarea propriei competențe de a identifica nevoile personale de formare profesională continuă. În acest caz, trebuie utilizat întregul *Set de instrumente pentru verificarea competenței*. Poate fi utilizat de orice furnizor de servicii de îngrijire directă atât pentru autoevaluare, cât și pentru autoperfecționare sau ca metodă de a discuta obiectivele anuale cu superiorul ierarhic (*autoevaluare*).
- ✓ Verificarea competențelor tuturor furnizorilor de servicii de îngrijire directă care activează într-o anumită unitate, pentru a confirma respectarea unuia sau mai multor pași specifici. În acest caz, se vor utiliza numai competențele identificate pentru pașii respectivi (*evaluare inter pares, verificarea continuă a competenței, evaluarea echipei*).
- ✓ Efectuarea unei monitorizări interne a competențelor înainte de proiectarea unor sesiuni de formare sau cicluri de îmbunătățire a calității. În acest caz, poate fi utilizat întregul Set de instrumente pentru verificarea competenței, aplicat tuturor furnizorilor de servicii de îngrijire directă sau numai unora dintre aceștia, într-o perioadă de timp determinată, sau se pot verifica doar anumite competențe, de exemplu, pentru aspecte cunoscute ca necesitând mai multă atenție (*dovezi privind activitatea zilnică, evaluarea echipei*).
- ✓ Efectuarea unei evaluări sau monitorizări interne a competențelor tuturor furnizorilor de servicii de îngrijire directă înainte de solicitarea unei evaluări externe. În acest caz, trebuie utilizat întregul Set de instrumente pentru verificarea competenței (*ca etalon, înainte de a iniția demersurile de îmbunătățire a competențelor sau de a solicita acreditarea externă*).

Flexibilitatea *Setului de instrumente pentru verificarea competenței* permite utilizarea sa în scopuri și în moduri diferite în vederea verificării în funcție de fiecare indicator de performanță (întrebări, studii de caz, observare în situații reale, observare în condiții de simulare etc.). De exemplu, o unitate sanitară poate decide verificarea competențelor tuturor furnizorilor de servicii de îngrijire directă pentru implementarea pasului patru în timpul nașterilor prin cezariană. Examinatorii pot alege să evalueze mai întâi cunoștințele tuturor furnizorilor, prin probe scrise, înainte de aplicarea metodei observării în sala de operație. De exemplu, dacă se constată curențe de cunoștințe, acestea trebuie soluționate în primul rând, înainte de a efectua evaluări cronofage, care nu ar face decât să confirme cunoștințele insuficiente în cadrul echipei. Pe de altă parte, examinatorii pot decide să aplice metoda observării tuturor turelor, pentru o perioadă determinată, pentru a identifica starea de fapt inițială, ca punct de referință pentru posibile cursuri de formare continuă a echipei chirurgicale. Oricare dintre aceste opțiuni este validă, iar decizia depinde de resursele și de scopurile unității sanitare.

Metode de verificare a competențelor

Există o varietate de metode acceptabile pentru verificarea competențelor furnizorilor de servicii de îngrijire directă în domeniul ISPC. Acestea includ, nelimitativ, următoarele:

- întrebări
- discuții bazate pe cazuri
- observarea directă a abilităților și atitudinilor.

Toate metodele au fost concepute pentru a obține informații de la persoana ale cărei competențe sunt verificate. Secțiunea 3 descrie instrumentele prevăzute pentru fiecare dintre aceste metode de evaluare. În fiecare caz, trebuie utilizat *Setul de instrumente pentru verificarea competenței* pentru a verifica corectitudinea procedurilor și a avea o bază pentru feedbackul obiectiv privind indicatorii de performanță în cazul cărora se impune îmbunătățirea sau consolidarea cunoștințelor, abilităților și/sau atitudinilor. La modul ideal, utilizarea unei abordări care presupune metode multiple va fi mai eficientă pentru sugestii și planuri remediale individualizate.

Examinatorii

Examinatorii, care sunt responsabili de verificarea competenței altor persoane, trebuie să dețină calificările și experiența corespunzătoare în contextul clinic al ISPC. Pot proveni din instituții de formare profesională inițială sau pot fi experți, furnizori de servicii clinice. Examinatorii își concentrează atenția asupra identificării lacunelor, nu în mod punitiv, ci de așa manieră încât să stimuleze dezvoltarea profesională. În acest sens, trebuie să dețină suficiente cunoștințe despre îngrijirile acordate în maternitate și practicile de hrănire a sugarului în context ISPC, pentru a identifica atât cunoștințele, abilitățile și/sau atitudinile corecte, cât și pe cele incorecte. Trebuie să aibă abilități și abilități adecvate de gândire critică, susținere a unui interviu și observare. Trebuie să fie obiectivi în procesul de colectare a datelor și capabili să examineze în detaliu furnizorul de servicii de îngrijire directă, fără a influența rezultatele. Toți examinatorii trebuie să fie atenți la detalii, pentru a asigura că răspunsurile sunt înregistrate complet și conform.

Toți examinatorii trebuie să evite conflictele de interese, în special cu companiile care produc și/sau comercializează alimente pentru sugari și copii mici sau biberone și tetine, sau cu companiile-mamă ori filialele acestora (1). Acest aspect este absolut necesar pentru a asigura că furnizorii de servicii de îngrijire directă protejează familiile împotriva presiunilor comerciale.



SETUL DE INSTRUMENTE

SECȚIUNEA 3: SETUL DE INSTRUMENTE

Fișa de verificare a competenței

Obiectivul *Fișei de verificare a competenței (anexele A și B)* este să înregistreze dacă furnizorii de servicii de îngrijire directă care oferă servicii de îngrijire și sprijin în domeniul alăptării dețin competențele minime necesare pentru a sprijini alăptarea la sân cu compasiune, în condiții de siguranță, prin prisma principiilor ISPC. *Fișa de verificare a competenței* va contribui la consolidarea încrederii furnizorilor de servicii de îngrijire directă în competențele proprii și ale echipei interdisciplinare, a răspunderii și mândriei profesionale a acestora. Scopul acestei verificări constă în a furniza un feedback util, care să fundamenteze demersurile ulterioare de perfecționare profesională, să stimuleze autorefecția și remedierea din proprie inițiativă a curențelor, să diferențeze furnizorii pentru a identifica necesarul de formare suplimentară, să consolideze valorile comune ale diferitelor categorii de furnizori din cadrul unei echipe clinice și să certifice competențele furnizorilor (6).

Indicatorii de performanță incluși în Fișă sunt structurați atât în funcție de competențe (**anexa A**), cât și de pașii ISPC (**anexa B**). Ambele perspective sunt valoroase, iar conținutul este același. Pentru autorii de programe de formare profesională din mediul academic, gruparea în funcție de competențe poate fi mai utilă. Unitățile sanitare care își propun îmbunătățirea calității pentru un singur pas sau pentru un set de pași pot constata că este mai utilă structurarea după cei zece pași, pentru că se pot concentra exclusiv pe indicatorii de performanță esențiali pentru pașii respectivi. Pentru a proceda în mod temeinic și consecvent, selectați o abordare și urmați-o pentru toate aspectele legate de verificarea competențelor unei persoane.

Indicatorii de performanță relevanți pentru mai mulți pași sunt enumerați în *Fișă* de mai multe ori, dacă indicatorul este relevant pentru mai mulți pași în **anexa B** (cu excepția indicatorilor de performanță de bază, care sunt relevanți pentru pașii 3-10, dar nu sunt repetați în cadrul instrumentului).

Fișa de verificare a competenței a fost concepută astfel încât examinatorul să poată compila rezultatele pentru toți indicatorii de performanță după aplicarea diferitelor metode de evaluare (întrebări, studii de caz, observare). *Fișa de verificare a competenței* definește mai întâi indicatorul de performanță, apoi enumeră răspunsurile anticipate, pentru a facilita completarea sa. Toate posibilele răspunsuri provin din documentele OMS și UNICEF, precum și din protocoalele Academy of Breastfeeding Medicine (ABM). Rezultatele sunt prezentate în funcție de indicatorii de performanță, fiind descrise sub forma „Competent” sau „Sunt necesare îmbunătățiri”, cea de a doua categorie cuprinzând exemple privind aspectele care trebuie îmbunătățite la respectivul furnizor de servicii de îngrijire directă. Pot fi adăugate în Fișă răspunsuri acceptate la nivel național, de exemplu, potrivit politicilor naționale în domeniul alăptării la sân sau *Codului*.

Fișa de verificare a competenței include o listă a tuturor indicatorilor de performanță. Fiecare indicator de performanță are secțiuni pentru următoarele informații:

- Denumirea indicatorului de performanță.
- În dreapta indicatorului de performanță se menționează metoda de verificare recomandată. De exemplu, dacă metoda precizată este „întrebare”, examinatorul va specifica, adăugând „probă orală”, „probă scrisă” sau „test online”. Dacă metoda este observarea, examinatorul va specifica locul unde este realizată observarea.
- Sub fiecare indicator de performanță sunt enumerate posibilele răspunsuri corecte. Fiecare indicator de performanță cuprinde instrucțiuni privind numărul minim de răspunsuri care trebuie furnizate sau demonstrate pentru a promova.
- A doua coloană, „Opțiuni specifice țării”, permite fiecărei țări să adauge răspunsurile anticipate, potrivit politicilor și ghidurilor naționale.

SECȚIUNEA 3: SETUL DE INSTRUMENTE

• Cea de a treia coloană specifică rezultatul „Competent”, în cazul în care examinatorul înregistrează rezultatele verificării în cadrul căreia furnizorul de servicii de îngrijire directă a demonstrat că îndeplinește acest indicator de performanță. În funcție de preferințele unității, se poate bifa, specifica „da” sau „ok” etc.

• În cea de a patra coloană, „Sunt necesare îmbunătățiri”, examinatorul înregistrează în scris rezultatele incomplete sau nesatisfăcătoare, specificând unde sunt necesare îmbunătățiri.

Caseta de mai jos indică modul în care poate fi completată o *Fișă de verificare a competenței*, cu titlu de exemplu.

Indicator de performanță și răspunsurile anticipate	Opțiuni specifice țării	Competent	Sunt necesare îmbunătățiri
35. Angrenează mama într-o conversație despre două aspecte legate de importanța plasării mamei și copilului împreună 24h/zi.	Observare <i>în salonul mamei</i>		
Utilizând abilitățile de bază, discutați despre importanța plasării mamei și copilului împreună: Pentru a învăța cum să recunoască semnele de foame la sugar și cum să răspundă la acestea. ✓ Pentru a facilita adoptarea practicii alăptării la sân. ✓ Pentru a facilita legătura/atașamentul mamă-copil ✓ Pentru a oferi posibilitatea hrănirii frecvente, fără restricții. ✓ Pentru a spori bunăstarea sugarului și a mamei (mai puțin stres). ✓ Pentru a îmbunătăți controlul infecțiilor (risc mai mic de transmitere a bolilor infecțioase).	<i>Pentru a preveni identificarea eronată a copilului</i>		<i>Nu a abordat îngrijorările mamei legate de faptul că este obosită și vrea să rămână singură, să preia personalul copilul. Ț-a spus doar să țină bebelușul lângă ea, ca să îl hrănească atunci când îi e foame.</i>

Fișa de verificare a competenței este un document oficial care trebuie păstrat la dosarul furnizorului de servicii de îngrijire directă, prin urmare trebuie completat cu acuratețe și cu grijă, pentru fiecare competență, în funcție de toți indicatorii de performanță. Examinatorii trebuie să se asigure că documentează cu acuratețe rezultatele în *Fișa de verificare a competenței*, ceea ce va ajuta furnizorii de servicii de îngrijire directă să își îmbunătățească continuu performanța și să lucreze mai eficace.

Resursa examinatorului

Deși *Fișa de verificare a competenței* enumeră numai posibile răspunsuri corecte, este important să fie identificate atât cunoștințele, abilitățile și atitudinile corecte, cât și cele incorecte. Pentru a veni în sprijinul examinatorilor, a fost elaborată *Resursa examinatorului (anexele C și D)*, care oferă îndrumări privind utilizarea *Fișei de verificare a competenței*. *Resursa examinatorului* cuprinde răspunsuri corespunzătoare și necorespunzătoare și resurse specifice pentru informații suplimentare. Aceasta constituie „soluția răspunsurilor” care cuantifică (și simplifică) munca examinatorului atunci când evaluează un furnizor de servicii de îngrijire directă. *Resursa examinatorului* poate fi utilizată pentru a sprijini luarea deciziei dacă furnizorul de îngrijire a demonstrat o competență.

Anexa C este structurată după competențe, iar **Anexa D** în funcție de pașii ISPC.

Resursa examinatorului cuprinde următoarele coloane, pentru fiecare indicator de performanță:

- Prima coloană indică posibile răspunsuri corecte, exact ca și în cazul *Fișei de verificare a competenței*.
- A doua coloană specifică nivelul la care trebuie evaluat indicatorul de performanță: cunoștințe, abilități și/sau atitudini.
- A treia coloană, „Răspunsuri/practici îngrijorătoare”, prezintă posibile răspunsuri perimate, incorecte sau îngrijorătoare. Fiecare țară poate modifica răspunsurile/practicile îngrijorătoare, în funcție de circumstanțele sale specifice.
- Ultima coloană, „Resurse recomandate”, enumeră documentele internaționale publicate de OMS și UNICEF, precum și protocoalele ABM care trebuie sugerate furnizorului de servicii de îngrijire directă atunci când se constată existența unor curențe în competențele sale.

SECȚIUNEA 3: SETUL DE INSTRUMENTE

Prezentăm mai jos *Resursa examinatorului* pentru indicatorul de performanță 63, cu titlu exemplificativ:

Indicator de performanță și răspunsurile anticipate	CDA	Răspunsuri/practici îngrijorătoare	Recomandări privind resursele
63. Descrie mamei cel puțin patru semnale de alertă că sugarul este subnutrit sau deshidratat, caz în care trebuie să contacteze un cadru sanitar, după externare.	Observare		
Utilizând abilitățile de bază, explică următoarele semnale: ✓ Doarme de obicei mai mult de patru ore. ✓ Copilul este apatic. ✓ Plâns iritat sau slab. ✓ Întotdeauna trează. ✓ Niciodată nu pare mulțumit. ✓ Incapacitatea de a suge. ✓ Peste 12 mese pe zi. ✓ Majoritatea meselor durează peste 30 de minute. ✓ Nu există semne de deglutiție după ce suge de trei-patru ori. ✓ Cantitate mică de urină pe tot parcursul zilei. ✓ Niciun scaun pe tot parcursul zilei. ✓ Febră.	C-D-A	✗ Nu observă sau omite să analizeze dacă există semne că sugarul este subnutrit. ✗ Nu poate enumera semnele subnutriției. ✗ Omite să observe semnele la mamă, le observă numai la copil. ✗ Susține că copilul doarme toată noaptea în prima săptămână. ✗ Afirmă că mama detestă să trezească copilul care doarme. ✗ Explică că toți copiii plâng și este mai bine să îl lase să plângă. ✗ Răspunde că, în acest stadiu precoce, este foarte bine să hrănească copilul doar de șase ori pe zi. ✗ Afirmă că, dacă copilul este la pieptul mamei, totul este în regulă. ✗ Insistă că mama trebuie să continue să încerce să pună copilul la sân. ✗ Explică faptul că nou-născutul nu urinează mult, iar aceste scutece sunt foarte absorbante. ✗ Îi spune mamei „Nicio grijă, e normal”, fără a verifica mai întâi semnele și simptomele. ✗ Afirmă că nu este necesară nicio evaluare atât de devreme. ✗ Răspunde evaziv îngrijorărilor mamei, afirmând: „O să înveți să-ți iubești copilul” sau „Bucură-te! Copilul tău este bine!”	• Materiale de formare ISPC 7. (4) • Materiale de formare ISPC 12. (4) • Materiale de formare ISPC 19 (4) • Modelul OMS Capitolul 5.5 și figura 15. 10. • Modelul OMS Capitolul 7.10 și tabelul 9. 10. • Protocolul 7 ABM. 11. • Protocolul 10 ABM. 17.

Resursa examinatorului poate fi utilizată pentru a forma noii examinatorii cu privire la așteptările din timpul verificării clinice a competențelor și/sau pentru a le reaminti care sunt răspunsurile acceptabile, care sunt cele discutabile și care sunt resursele disponibile pentru furnizorii de servicii de îngrijire directă în cazul cărora s-au constatat curențe în materie de competențe.

Întrebări cu variante multiple de răspuns pentru verificarea cunoștințelor

Adresarea întrebărilor constituie unul dintre cele mai simple instrumente pentru a obține răspunsuri de la o persoană. Constituie un element al fiecărui tip de verificare a competențelor, întrebările putând fi prezentate în scris, în format electronic sau verbal. Întrebările trebuie atent formulate, astfel încât să nu sugereze răspunsul. Întrebările deschise sunt cea mai bună opțiune, pentru că oferă cele mai multe șanse de a obține cel mai mare volum de informații, inclusiv la nivel atitudinal. Însă această abordare necesită mai mult timp din partea examinatorului. Întrebările închise (cu răspuns „da/nu”, „adevărat/fals”, sau variante multiple de răspuns) se utilizează pentru a obține un răspuns direct de la o persoană și/sau a-i solicita să confirme o informație. Întrebările cu variante multiple de răspuns constituie cea mai simplă și mai rapidă metodă de a verifica cunoștințele de bază, înainte de a observa o persoană în acțiune. *Resursa examinatorului* prezintă un eșantion de întrebări cu variante multiple de răspuns (online **Anexa E**).

Caseta de mai jos ilustrează cu titlu exemplificativ o întrebare cu variante multiple de răspuns:

Atunci când copilul este plasat în contact piele-pe-piele cu mama la naștere, ce comportament ar trebui să aibă instinctiv înainte de a fi ghidat spre mamelon, în poziția de supt? (PI #27)

- Se liniștește încetul cu încetul, astfel încât cineva îl poate ajuta să apuce mamelonul
- Plânge tare, apoi se odihnește, fără a mișca.
- Se îndreaptă spre sân și atinge corpul și pieptul mamei.
- Lent, este cuprins de un somn profund, iar apoi începe să își miște mâinile și picioarele.

Eșantionul de întrebări include cel puțin o întrebare pentru fiecare indicator de performanță. Țările pot adapta și suplimenta setul, în funcție de circumstanțele lor specifice.

Studii de caz pentru verificarea integrală a cunoștințelor

O discuție pe marginea unui studiu de caz între un furnizor de servicii de îngrijire directă și un examinator implică o analiză completă a unei situații clinice. I se prezintă furnizorului un scenariu clinic simulat și i se adresează întrebări pentru a explica ce ar face în mod normal, dacă ar întâlni situația respectivă în viața reală. Această metodă promovează reflecția, curiozitatea critică și raționamentul clinic și necesită mai mult timp decât întrebările scrise, însă, de obicei, extrage mai multe informații, datorită fluxului discuției. Studiile de caz trebuie atent concepute, astfel încât să reprezinte activitatea obișnuită a diferitelor categorii de furnizori de servicii de îngrijire directă din cadrul unei echipe. De exemplu, un scenariu care presupune extragerea laptelui poate să nu fie potrivit pentru medici, această activitate fiind, ca regulă, apanajul asistentelor medicale sau al moașelor, deci există așteptarea ca medicii să direcționeze întrebarea către persoana cea mai competentă să răspundă nevoilor mamei din echipa clinică. În mod similar, este posibil ca un studiu de caz care presupune prescrierea medicației corecte pentru mamă să nu constituie opțiunea potrivită pentru anumite categorii de furnizori de servicii de îngrijire directă. Prin verificarea competențelor tuturor furnizorilor de servicii de îngrijire directă dintr-o echipă dată, unitatea sanitară se poate asigura că oferă îngrijiri în mod profesionist, prin intermediul unei echipe responsabile.

Manualul de față cuprinde un eșantion de studii de caz (**anexa F**) cu întrebări deschise privind situații clinice întâlnite în mod tipic pretutindeni în lume. Acestea vizează competențe specifice sau competențe conexe.

Caseta de mai jos ilustrează cu titlu exemplificativ un studiu de caz despre îngrijirea la naștere și post-partum.

Studiu de caz 4: Naștere și imediat post-partum

Georgina și Giuseppe se prezintă la maternitate deoarece contracțiile au devenit regulate și puternice. Sunt repartizați într-un salon, iar furnizorul de servicii de îngrijire directă o examinează, apoi evaluează cunoștințele cuplului despre procesul nașterii și procedurile post-partum.

Ce informații ar putea furniza acestui cuplu despre importanța contactului imediat și neîntrerupt piele-pe-piele, chiar de la naștere, pentru mamă? (PI #18)

- Temperatură în limite normale.
- Placenta expulzată la timp, ca urmare a valului de oxitocină eliberat în organismul mamei, deci anemie postnatală mai redusă.
- Nivelul crescut de oxitocină duce la o involuție uterină adecvată, asigurând lactația.
- Nivelul gastrinei serice rămâne scăzut, ceea ce înseamnă mai puțin stres pentru mamă.
- Este facilitată lactația, datorită aportului hormonal care survine ca urmare a contactului piele-pe-piele al mamei cu copilul.
- Este facilitată crearea legăturii afective (contacte vizuale, atingeri, poziționare față în față, comportamente pline de afecțiune).
- Vocea și gesturile mamei sunt blânde, dând dovadă de răbdare în încercările de a ghida copilul către mamelon, în poziția de supt, sau de a-l stimula.
- Sentimentul de stare de bine al mamei (niveluri crescute de oxitocină și endorfine).
- Mai puține simptome depresive postnatale.
- Un risc mai mic de neglijare și abandon al copilului.
- Reciprocitate; sensibilitate sporită a mamei.
- Mama își poate calma copilul cu mai multă ușurință.

Instrumente pentru verificarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor prin metoda observării

Observarea directă este folosită în majoritatea cazurilor pentru a verifica competențele în timpul interacțiunii cu gravidele și cu mamele. Pentru a asigura obiectivitatea activității de observare, în viața reală sau în condiții de simulare, se utilizează un instrument de observare care descrie comportamentele anticipate, iar examinatorul verifică pur și simplu comportamentele observate și își notează observațiile în *Fișa de verificare a competenței*. Observarea în situații de viață reală permite furnizorilor de servicii de îngrijire directă să își demonstreze competența la patul pacientei, prin îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți.

Laboratorul de simulare constituie un mediu clinic creat care permite exersarea sau demonstrarea cunoștințelor/abilităților într-un mediu simulat. Atunci când există un astfel de laborator amenajat, acesta dispune de toate echipamentele și instrumentele disponibile în practica clinică și poate implica utilizarea unui pacient standard sau a unui manechin. Examinatorul care utilizează această metodă prezintă un caz persoanei examinate și o observă în timp ce aplică procedura și răspunde la întrebări.

Manualul de față include un set de instrumente de observare (**anexa G**), denumite și instrumente de audit pentru pasul doi, de aplicat atunci când este necesară observarea unei competențe pentru a verifica cunoștințe, abilități și atitudini care nu pot fi adecvat evaluate prin întrebări, adresate în scris sau oral.

De exemplu, caseta de mai jos ilustrează un instrument pentru observarea unei discuții antenatale despre alăptarea la sân, pentru mai mulți indicatori de performanță.

Instrument de observare 1:**Încurajarea discuțiilor pe tema alăptării la sân în perioada antenatală
(PI #15, 16, 17, 29)**

**Vă rugăm să verificați TOATE elementele în timpul observării unei situații clinice
ȘI să consultați Resursa examinatorului pentru detalierea răspunsurilor anticipate**

Bifați după cum urmează:

- D = Da, aspectul a fost observat și este corect
 N = Nu, aspectul a fost observat și nu este corect
 NS = Nu sunt sigur/ă, aspectul a fost observat, însă examinatorul nu este sigur dacă este corect sau nu
 N/A = Nu se aplică

ELEMENTUL CARE FACE OBIECTUL OBSERVĂRII	D	N	NS	N/A	OBSERVAȚII
Utilizarea abilităților de bază pe tot parcursul interacțiunii (PI #11, 12, 13, 14)					

16. Evaluează cel puțin 3 aspecte legate de cunoștințele mamei despre alăptatul la sân, pentru a completa lacunele și a corecta inexactitățile

Discută informații suplimentare despre alăptatul la sân, în funcție de nevoile și îngrijorările gravidei, inclusiv:					
Alăptarea exclusivă la sân (AES)					
Inițierea și continuarea alăptării la sân					
Contact piele-pe-piele imediat după naștere					
Tipare de alăptare tipice					
Hrănire receptivă și semne de foame					
Mama și copilul sunt în permanență împreună, fiind plasați în același salon					
Importanța colostrului					
Îngrijirea post-partum pentru a sprijini alăptarea la sân					
Sprijinirea deciziilor în cunoștință de cauză privind hrănirea sugarului					



ADAPTARE ÎN FUNCTIE DE SPECÍFICUL ȚĂRII

SECȚIUNEA 4: ADAPTARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȚĂRII

Competențele ISPC descrise în manualul de față trebuie privite ca reprezentând ansamblul minim de cunoștințe, abilități și atitudini pe care trebuie să le aibă furnizorii de servicii de îngrijire directă pentru a proteja, promova și sprijini în mod adecvat alăptarea la sân.

Indicatorii de performanță și instrumentele prezentate aici au scopul de a sprijini țările și sistemele de sănătate în demersurile de verificare a acestor competențe. Ca atare, fiecare țară își poate propune să definească indicatori de performanță suplimentari sau să îi modifice, integral sau parțial, pe cei prezentați.

Fișa de verificare a competenței poate fi editată pentru a reflecta mai bine specificul conferit prin politicile și ghidurile naționale. Fișa poate include coloane suplimentare, pentru a înregistra mai multe informații pertinente. Cu toate acestea, țările trebuie să se asigure că nu complică excesiv instrumentul, astfel încât implementarea acestuia să rămână fezabilă.

Resursa examinatorului poate fi modificată pentru a insera acte normative sau ghiduri naționale care reflectă practicile bazate pe dovezi din fiecare țară sau pentru a specifica răspunsurile sau comportamentele inadecvate identificate adesea în țara respectivă.

Există multe alte metode de a evalua competențele clinice, în afară de cele prezentate în manualul de față. Întrebările cu variante multiple de răspuns, studiile de caz și observarea directă constituie metodele cele mai simple, mai puțin costisitoare și mai cunoscute la nivel mondial. Țările sau sistemele de sănătate pot utiliza instrumentele de verificare ca pe un șablon, pentru a adapta și include instrumente de verificare suplimentare, precum examenele orale, eseurile, simulările de laborator sau studiile de caz reflectând situații de viață reală, cu colegii, după cum consideră potrivit. Este foarte probabil că în majoritatea țărilor se va aprecia că se impun întrebări, studii de caz sau liste de verificare pentru observare suplimentare.

BIBLIOGRAFIE

1. World Health Organization, UNICEF. Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services – the revised Baby-Friendly Hospital Initiative. Geneva: World Health Organization; 2018 (<http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/>, accessed 16 July 2020).
2. World Health Organization, UNICEF. Global strategy for infant and young child feeding. Geneva: World Health Organization; 2003 (<http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241562218/en/index.html>, accessed 16 July 2020).
3. World Health Organization. Roles and responsibilities of government chief nursing and midwifery officers: a capacity-building manual. Geneva: World Health Organization; 2015 (https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/cnow/en/, accessed 16 July 2020).
4. World Health Organization, UNICEF. Baby-friendly Hospital Initiative: training course for maternity staff. Geneva: World Health Organization; 2020.
5. World Health Organization. Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. Geneva: World Health Organization; 2010 (<https://www.who.int/publications-detail/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice>, accessed 16 July 2020).
6. Epstein RM, Hundert MM. Defining and assessing professional competence. JAMA. 2002;287(2):226-35.
7. UNICEF, World Health Organization. The introductory course on the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. New York: UNICEF; 2014 (<https://agora.unicef.org/course/info.php?id=12360>, accessed 17 July 2020).
8. World Health Organization. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Geneva: World Health Organization; 1981 (http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf, accessed 17 July 2020).
9. World Health Organization. Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children. In: Sixty-ninth World Health Assembly, Geneva, 23–28 May 2016. Provisional agenda item 12.1. Geneva: World Health Organization; 2016.
10. World Health Organization. Infant and young child feeding: model chapter. Geneva: World Health Organization; 2009.
11. Hernández-Aguilar MT, Bartick M, Schreck P, Harrel C, Academy of Breastfeeding Medicine. ABM Clinical Protocol #7: Model maternity policy supportive of breastfeeding. Breastfeed Med. 2018;13(9):559-74 doi:10.1089/bfm.2018.29110.mha.
12. World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies. Geneva: World Health Organization; 2010 (https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf, accessed 17 July 2020).
13. World Health Organization. Guideline: counselling of women to improve breastfeeding practices. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/counselling-women-improve-bf-practices/en/>, accessed 17 July 2020).
14. Rosen-Carole C, Hartman S. ABM Clinical Protocol #19: Breastfeeding promotion in the prenatal setting. Breastfeed Med. 2015;10(10):451-7 doi:10.1089/bfm.2015.29016.ros

15. World Health Organization. WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018 (<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/>, accessed 17 July 2020).
16. Holmes AV, McLeod AY, Bunik M. ABM Clinical Protocol #5: Peripartum breastfeeding management for the healthy mother and infant at term. *Breastfeed Med.* 2013;8(6):469-73 doi:10.1089/bfm.2013.9979.
17. Boies EG, Vaucher YE. ABM Clinical Protocol #10: Breastfeeding the late preterm (34-36 6/7 weeks of gestation) and early term infants (37-38 6/7 weeks of gestation). *Breastfeed Med.* 2016;11(10):494-500 doi:10.1089/bfm.2016.29031.egb.
18. Reece-Stremtan S, Gray L, Academy of Breastfeeding Medicine. ABM Clinical Protocol #23: Nonpharmacological management of procedure-related pain in the breastfeeding infant, Revised 2016. *Breastfeed Med.* 2016;11(9) (<https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/bfm.2016.29025.srs>, accessed 16 July 2020).
19. World Health Organization, UNICEF. Frequently asked questions. Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-Friendly Hospital Initiative 2018 implementation guidance. Geneva: World Health Organization; 2020 (<https://www.who.int/publications-detail/9789240001459>, accessed 17 July 2020).
20. Evans A, Marinelli KA, Taylor JS. ABM Clinical Protocol #2: Guidelines for hospital discharge of the breastfeeding term newborn and mother: "The going home protocol". *Breastfeed Med.* 2014;9(1):3-8 doi:10.1089/bfm.2014.9996.
21. Blair PS, Ball H L, McKenna J J, Feldman-Winter L, Marinelli KA, Bartick M C et al. Bedsharing and breastfeeding: The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol #6. *Breastfeed Med.* 2020;15(1):1-12 doi:10.1089/bfm.2019.29144.psb.
22. Noble LM, Okogbule-Wonodi AC, Young MA. ABM Clinical Protocol #12: Transitioning the breastfed-ing preterm infant from the neonatal intensive care unit to home. *Breastfeed Med.* 2018;13(4):230-6 doi:10.1089/bfm.2018.29090.ljn.
23. World Health Organization. Clinical management of COVID-19: interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2020 (May) (<https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19>, accessed 15 July 2020).
24. UNICEF United Kingdom. Responsive Feeding Infosheet. 2016. (<https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/relationship-building-resources/responsive-feeding-infosheet/>, accessed 13 July 2020).
25. Eglash A, Simon L, Medici T, Academy of Breastfeeding Medicine. ABM Clinical Protocol #8: Human milk storage information for home use for full-term infants. *Breastfeed Med.* 2017;12(7):390-5 doi:10.1089/bfm.2017.29047.aje.
26. Thomas J, Marinelli KA, Academy of Breastfeeding Medicine. ABM Clinical Protocol #16: Breastfeeding the hypotonic infant. *Breastfeed Med.* 2016;11(6):271-6 doi:10.1089/bfm.2016.29014.jat.
27. Nyqvist KH, Maastrup R, Hansen MN, Haggkvist AP, Hannula L, Ezeonodo A et al. Neo-BFHI: the Baby-Friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Core document with recommended standards and criteria. 2015 (<http://portal.ilca.org/files/resources/Neo-BFHI%20Core%20document%202015%20Edition.pdf>, accessed 17 July 2020).

28. World Health Organization. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts: interim guidance. 17 March 2020 ([https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts](https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts), accessed 17 July 2020).
29. Kellams A, Harrel C, O'age S, Gregory C, Rosen-Carole C. ABM Clinical Protocol #3: Supplementary feedings in the healthy term breastfed neonate. *Breastfeed Med*. 2017;12(3):1-11 doi:10.1089/bfm.2017.29038.ajk.
30. World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Guidelines for the safe preparation, storage and handling of powdered infant formula. Geneva: World Health Organization; 2007 (<https://www.who.int/publications-detail/safe-preparation-storage-and-handling-of-powdered-infant-formula>, accessed 17 July 2020).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Department of Nutrition and Food Safety

www.who.int/nutrition

Email: nutrition@who.int

World Health Organization

Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland



**World Health
Organization**

